CADO ODONTOLOGIA · CALAMA

Dr. Javier Beiza Ayala | Cirujano Dentista Titular (13 anos en Calama)

Vivar #1580 Of. 203, Edificio Espacio Parque | Urgencias & WhatsApp: +56 9 4465 7815

GUIA DE INTERVENCION RAPIDA COMUNITARIA

Primeros Auxilios ante Urgencias Dentales y Dolor Agudo

Protocolo de estabilizacion en casa ante traumatismos, dolor severo y fracturas

Saber como actuar durante los primeros minutos de un accidente dental puede marcar la diferencia entre o salvar perder una pieza dental definitiva.

1. Diente definitivo expulsado por completo (Avulsion)

- Buscar el diente de inmediato. Tomarlo SIEMPRE por la corona (la parte blanca), NUNCA tocar la raiz.
- Si esta sucio, enjuagarlo por 10 segundos con agua fria o suero sin frotar ni cepillar.
- Transporte urgente: colocarlo en un vaso con leche fria, suero fisiologico o dentro de la boca (junto a la mejilla si el paciente es cooperador).
- Acudir a CADO o servicio dental antes de 60 minutos: es la ventana de maxima viabilidad.

2. Diente fracturado o quebrado

- Recuperar los fragmentos fracturados y guardarlos en agua limpia o suero; frecuentemente se pueden readherir.
- Enjuagar suavemente la boca con agua tibia para eliminar restos de sangre o comida.
- Aplicar frio local exterior si hubo impacto en el labio o mejilla para contener la hinchazon.

3. Dolor dental agudo nocturno o espontaneo

- Pasar seda dental con extrema delicadeza para descartar restos de comida atrapados entre los dientes.
- Realizar enjuagues tibios con agua y una pizca de sal. No aplicar calor directo en la cara.
- NUNCA colocar pastillas de aspirina, alcohol, ajo ni remedios caseros sobre la encia: provocan quemaduras quimicas severas.

4. Absceso o flemom con aumento de volumen facial

- No apretar, pinchar ni intentar drenar la inflamacion por cuenta propia.
- Mantener la cabeza elevada con almohadas durante el descanso.
- Contactar a CADO de inmediato para prescripcion de antibioterapia y drenaje profesional en consultorio.

CUANDO ACUDIR A URGENCIA HOSPITALARIA INMEDIATA

! Inflamacion severa del cuello o piso de la boca que dificulta respirar o deglutir saliva.

! Hemorragia bucal profusa secundaria a traumatismo facial que no cede con compresion.

! Traumatismo facial de alta energia con perdida de consciencia, mareo o vomitos.